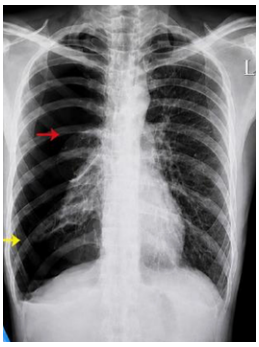
# PLEURA, PULMÓN Y MEDIASTINO

DR. RICARDO JARAMILLO / DR. GERARDO VICTORIA

### NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO

- Resulta de la ruptura de una bula subpleural; con escape de aire grande se produce un neumotórax a tensión que compromete la vida.
- 80% ocurre en jóvenes sin enfermedad pulmonar previa (bulas apicales); en mayores de 40 años se asocia a enfisema por tabaquismo.
- Recurrencia: 50% tras el primer episodio, 62% tras el segundo y 80% tras el tercero.
- Síntomas: dolor y dificultad respiratoria que aumenta con el tamaño.



### EMPIEMA

- Infección de la cavidad pleural; causa principal: neumonía (también trauma, infarto pulmonar, resecciones o causas intraabdominales).
- Diagnóstico: pus franca, bacterias en frotis/cultivo, o consumo de glucosa, pH bajo y DHL >1000.

### FASES DEL EMPIEMA

- Fase I (aguda supurativa): toracocentesis o tubo pleural.
- Fase II (fibrinopurulenta): videotoracoscopia.
- Fase III (crónica): toracotomía y decorticación formal.

### TORACOCENTESIS

- Extracción de líquido o aire del espacio pleural con aguja o catéter percutáneo.

### PLEUROSCOPIA

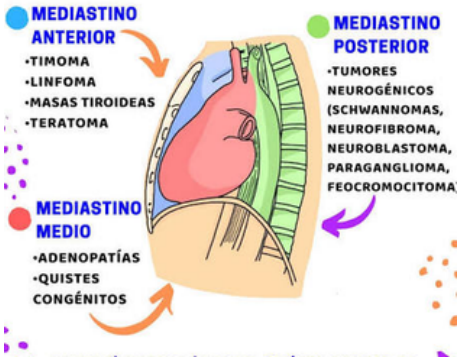
- Observación y biopsia de la cavidad pleural con toracoscopio; evita incisiones convencionales y acorta la estancia.

### COMPARTIMIENTOS DEL MEDIASTINO

- Anterosuperior: timoma, linfoma y tumor de células germinales.
- Medio: quistes pericárdicos, linfomas y quistes broncogénicos.
- Posterior: tumores neurogénicos y quistes broncogénicos y entéricos.

### LÍMITES DEL MEDIASTINO

- Anterior: esternón. Posterior: cuerpos vertebrales y costillas. Laterales: pleuras mediastínicas. Superior: estrecho torácico superior. Inferior: diafragma e hiatos.




### EFUSIÓN PLEURAL MALIGNA

- Interferencia del drenaje linfático y venoso por invasión tumoral; causas en orden: pulmón, mama y gastrointestinal; signo de mal pronóstico.
- Tratamiento paliativo: evacuación con tubo pleural y pleurodesis; si hay loculaciones y el pulmón no se expande, la pleurodesis no será efectiva.

### CÁNCER DE PULMÓN

- Dos grupos: células pequeñas (crecimiento rápido, más metastásico, mejor respuesta a quimio/radioterapia) y células no pequeñas (80%: adenocarcinoma 50%, escamoso 30%, células grandes).
- El tabaquismo es el elemento más importante en la patogénesis; solo 6% están asintomáticos al diagnóstico.
- La mediastinoscopia es clave para la estadificación ganglionar antes de la cirugía.

# PLEURA, PULMÓN Y MEDIASTINO

DR. RICARDO JARAMILLO / DR. GERARDO VICTORIA

**SÍNTOMAS DE TUMORES CENTRALES**

- Tos (el más común), estridor, sibilancias, hemoptisis, disnea y dolor precordial.

**SÍNTOMAS DE TUMORES PERIFÉRICOS**

- Dolor precordial, tos y disnea por afección pleural y torácica; algunos se manifiestan como abscesos.
- Invasión del recurrente: disfonía; compresión esofágica: disfagia.

**SÍNDROME DE PANCOAST**

- Extensión del tumor al ápice pulmonar con dolor en hombro y brazo.

**SÍNDROME DE HORNER**

- Afección del simpático: enoftalmos, miosis, ptosis y anhidrosis facial.

**SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR**

- Disnea, ortopnea, cefalea, edema facial y de miembros superiores, náuseas y dificultad para concentrarse.
- Causas: carcinoma bronquial 87%, linfomas 10%, benignos 3%; biopsia percutánea antes del tratamiento empírico.

**SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS**

- Hipercalcemia, Cushing por ACTH ectópica, dedos en palillo de tambor y secreción inapropiada de ADH.

**PRESENTACIÓN CLÍNICA**

- Broncopulmonares: tos (75%), hemoptisis (57%), dolor torácico, disnea, infección.
- Metastásicos: neurológicos, dolor óseo, fracturas, ictericia, ascitis; inespecíficos: pérdida de peso, anorexia, debilidad, palidez.
- La mayoría tiene síntomas por 3–6 meses.

**ESTADIOS Y CANDIDATOS A CIRUGÍA**

- Estadios I y II se benefician de la cirugía; IIIA: terapia de inducción y, según respuesta, cirugía.
- IIIB: cualquier T con N3 o T4; IV: cualquier M1.

**VIABILIDAD DE LA CIRUGÍA**

- Espirometría; si es limítrofe, centelleo de ventilación para calcular la reserva posquirúrgica.
- FEV1 residual no menor de 0,9 L.

**TIMOMA**

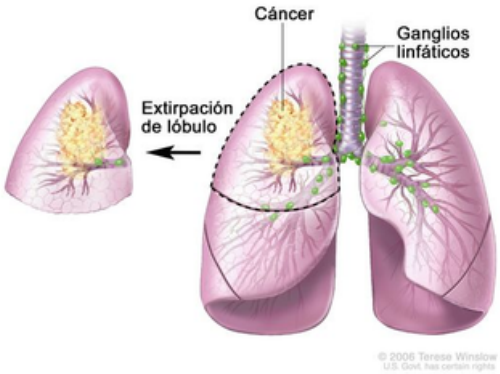
- Neoplasia más frecuente del mediastino anterosuperior (30–50 años); el síndrome asociado más frecuente es la miastenia gravis.

**TIPO DE RESECCIÓN**

- Lobectomía: la más realizada; neumonectomía si la lobectomía no logra resección completa y el paciente la tolera; cuña en lesiones periféricas pequeñas con alto riesgo o mala reserva.

**PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN**

- Sobrevida a 5 años: estadio I ~80%, II 40–50%, IIIA 10–20%; la terapia de inducción parece mejorar la del estadio III.




**SEROLOGÍA: AFP Y GCH**

- Varón de 20–50 años con masa anterosuperior: si son positivas indican tumor germinal no seminomatoso; puede iniciarse quimioterapia sin cirugía.

**TUMORES NEUROGÉNICOS**

- Mediastino posterior, desde ganglios simpáticos; benignos en adultos y malignos en niños; ~10% se extiende a la columna (en mancuerna): TAC y RM.

**LINFOMA MEDIASTINAL**

- No es quirúrgico: biopsia percutánea, de ganglios cervicales, mediastinotomía, mediastinoscopia o toracoscopia.

**TERATOMA**

- Varios tipos de tejidos; mediastino anterior; dos tercios asintomáticos; tratamiento quirúrgico.

**SEMINOMA**

- El más común de los germinales; hombres jóvenes; sintomático en 80%; AFP y GCH casi siempre normales.

**TUMORES NO SEMINOMATOSOS**

- Hombres jóvenes; elevación característica de AFP y GCH, que permite iniciar quimioterapia.

**MIASTENIA GRAVIS**

- Anticuerpos contra receptores de acetilcolina; tratamiento: timectomía (esternal, cervical o toracoscópica).